

Cours De Résidanat

Sujet : 38

Hypertension artérielle

Épidémiologie, Physiopathologie, Diagnostic, Complication, Traitement.

Concours ECN 2025

Pr Ag Amine BAHLOUL

Objectif 1

Mécanismes physiologiques de la régulation nerveuse et hormonale de la PA

1- Lors d'une hausse brusque de la pression artérielle, le baroréflexe provoque principalement :

- A. Augmentation de l'activité sympathique
- B. Diminution de l'activité sympathique
- C. Augmentation du tonus vagal
- D. Sécrétion immédiate d'aldostérone
- E. Libération d'ADH par la neurohypophyse

Réponses : B, C

2- Les barorécepteurs à haute pression sont situés principalement :

- A. Dans le sinus carotidien et la crosse aortique
- B. Dans l'oreillette droite
- C. Dans les artérioles rénales
- D. Dans la veine cave inférieure
- E. Dans la médullosurrénale

Réponses : A

3- L'activation du système sympathique augmente la pression artérielle par :

- A. Vasoconstriction via récepteurs α_1
- B. Augmentation de la fréquence cardiaque via récepteurs β_1
- C. Inhibition de la rénine rénale
- D. Vasodilatation via récepteurs β_2 dans tous les territoires
- E. Stimulation de la médullosurrénale et libération de catécholamines

Réponses : A,B, E

4- Concernant le SRAA (système rénine-angiotensine-aldostérone) :

- A. La rénine convertit l'angiotensinogène en angiotensine I
- B. L'angiotensine II est un puissant vasodilatateur
- C. L'angiotensine II stimule la sécrétion d'aldostérone
- D. L'aldostérone augmente la réabsorption de sodium au tubule distal
- E. L'angiotensine II inhibe la sensation de soif

Réponses : A,C, D

5- L'hormone antidiurétique (ADH) augmente la PA par :

- A. Réabsorption rénale d'eau au niveau du tube collecteur
- B. Effet vasoconstricteur direct systémique
- C. Sécrétion par la neurohypophyse en réponse à l'hyperosmolarité et à l'hypovolémie
- D. Augmentation de la filtration glomérulaire (DFG)
- E. Inhibition du SRAA

Réponses : A,B, C

6- L'hormone antidiurétique (ADH) :

- A. Est libérée en cas d'hypovolémie
- B. Diminue la réabsorption d'eau au niveau rénal
- C. Augmente le volume extracellulaire
- D. Possède un effet vasoconstricteur à forte concentration
- E. Est inhibée par l'hyperosmolarité plasmatique

Réponses : A, C, D

7- Le facteur atrial natriurétique (FAN) a pour effets :

- A. Augmentation de la natriurèse et diurèse
- B. Vasodilatation et baisse des résistances périphériques
- C. Stimulation de la sécrétion d'aldostérone
- D. Inhibition de la sécrétion d'ADH
- E. Augmentation de la réabsorption tubulaire de sodium

Réponses : A,B, D

8- Lors d'une hémorragie aiguë (baisse de la volémie), quel est le schéma physiologique attendu ?

- A. Baisse de la stimulation des barorécepteurs → levée de l'inhibition du sympathique
- B. Augmentation de la stimulation du NTS → augmentation du tonus parasympathique
- C. Stimulation du sympathique → libération de rénine par le rein
- D. Diminution de la sécrétion d'ADH
- E. Activation de la soif via le système nerveux central

Réponses : A,C, E

9- Les effets cardiaques de la stimulation sympathique incluent :

- A. Effet chronotrope positif
- B. Effet inotrope positif
- C. Effet lusitrope positif
- D. Diminution de la conductivité auriculo-ventriculaire
- E. Effet bathmotrope positif

Réponses : A,B, C, E

10- Concernant la régulation locale de la vasomotricité, lesquels sont des puissants vasodilatateurs endothéliaux ?

- A. Endothéline-1
- B. Monoxyde d'azote (NO)
- C. Thromboxane A2
- D. Prostaglandine F2
- E. Bradykinine

Réponses : B, E

Objectif 2

Mécanismes physiopathologiques de l'hypertension artérielle

11- L'HTA dite « de volume » se caractérise par :

- A. Débit cardiaque élevé avec RPT normales
- B. Souvent retrouvée chez le sujet jeune
- C. Résulte d'une rétention sodée ou d'un tonus veineux augmenté
- D. Est typiquement due à une rigidité artérielle isolée chez le sujet âgé
- E. Associée à un SRAA activé

Réponses : A, B, C, E

12- L'HTA « de résistance » décrit :

- A. RPT élevées avec débit cardiaque normal
- B. Survient surtout chez les personnes âgées
- C. Est d'abord fonctionnelle puis peut devenir organique (remodelage pariétal)
- D. Est principalement liée à une hypervolémie aiguë
- E. Est associée à dysfonction endothéliale

Réponses : A, B, C, E

13- Parmi les mécanismes contribuant à l'HTA essentielle :

- A. Hyperstimulation sympathique
- B. Hyperactivation du SRAA
- C. Incapacité rénale à excréter Na^+
- D. Infection bactérienne chronique
- E. Mutations monogéniques toujours retrouvées

Réponses : A, B, C

14- La dysfonction endothéliale favorise l'HTA en :

- A. Augmentant la libération de facteurs vasoconstricteurs (ex : endothéline)
- B. Réduisant la production de NO vasodilatateur
- C. Accélérant le processus d'athérosclérose
- D. Favorisant une altération du tonus artériolaire
- E. Diminution de la réactivité aux catécholamines

Réponses : A, B, C, D

15- L'augmentation des résistances périphériques est fortement influencée par :

- A. Le rayon des vaisseaux (loi de Poiseuille)
- B. La longueur des vaisseaux
- C. La viscosité du sang
- D. Le débit cardiaque
- E. Des facteurs locaux métaboliques (adénosine, lactates...)

Réponses : A, B, C, E

16- Un patient âgé avec HTA isolée systolique a le (s) mécanisme principal (aux) suivant (s) :

- A. Diminution de l'élasticité artérielle (rigidité)
- B. Augmentation de la compliance aortique
- C. L'hypervolémie
- D. Remaniement artériel avec augmentation des RPT
- E. L'hyperactivité sympathique

Réponses : A

17- L'augmentation de la PAM peut être due à :

- A. Augmentation du débit cardiaque
- B. Augmentation des résistances périphériques totales
- C. Diminution de la viscosité sanguine
- D. Diminution du volume intravasculaire
- E. Vasoconstriction artériolaire

Réponses : A, B, E

18- Le rôle du système nerveux parasympathique dans la régulation des RPT est :

- A. Principal et déterminant sur les artérioles systémiques
- B. Limité, il agit surtout sur le cœur et quelques organes spécifiques
- C. Responsable d'une vasodilatation systémique majeure
- D. Indirect via modulation du sympathique par le NTS
- E. Nul, vu qu'il n'y a pas de récepteurs muscariniques au niveau des vaisseaux

Réponses : B, D

19- Le parasympathique dans la régulation tensionnelle :

- A. Possède un effet vasomoteur majeur
- B. Est limité à l'innervation cardiaque
- C. Intervient par modulation du sympathique via le NTS
- D. Provoque une vasodilatation systémique
- E. N'a pas d'action directe sur les RPT

Réponses : B, C, E

20- Concernant la classification physiopathologique, la phrase « HTA essentielle » signifie :

- A. Cause identifiable dans 95% des cas
- B. Résultante d'une interaction environnement/terrain génétique
- C. Parfois liée à une incapacité rénale à éliminer le sodium
- D. Parfois due à un adénome surrénalien
- E. Peut associer hyperactivation sympathique et SRAA

Réponses : B, C, E

Objectif 3

Facteurs de risque de l'HTA de l'adulte

21- Parmi les facteurs de risque majeurs listés, lesquels appartiennent à la catégorie « majeurs » ?

A. Diabète de type 2

B. Tabac

C. Dyslipidémie athérogène (ex. LDL élevé)

D. Âge ≥ 55 ans chez l'homme (≥ 65 chez la femme)

E. Syndrome d'apnées du sommeil

Réponses : A, B, C, D

22- Le syndrome métabolique est défini par la présence d'au moins 3 critères ; lesquels parmi ceux-ci en font partie ?

- A. Obésité abdominale (tour de taille > 94 cm homme / > 80 cm femme)
- B. Glycémie à jeun > 1 g/L
- C. PA $\geq$ 130/85 mmHg ou HTA traitée
- D. HDL cholestérol élevé (>0.6 g/dL)
- E. Hypertriglycéridémie $\geq$ 1.5 g/L

Réponses : A, B, C, E

23- Les facteurs modifiables de risque d'HTA comprennent :

- A. Sédentarité
- B. Consommation excessive d'alcool (>3 verres/j homme)
- C. Tabagisme
- D. Antécédents familiaux d'HTA
- E. Régime riche en sel et graisses animales

Réponses : A, B, C, E

24- Parmi ces affirmations, lesquelles sont vraies concernant l'âge et la prévalence de l'HTA :

- A. La prévalence augmente avec l'âge
- B. Plus de 50% des personnes ≥ 65 ans peuvent être hypertendues
- C. L'HTA est rare chez les sujets âgés
- D. Le risque lié à PAS augmente linéairement dès 115/75 mmHg
- E. L'HTA multiplie le risque d'AVC (selon Framingham)

Réponses : A, B, D, E

25- Le(s) facteur(s) suivant(s) est/sont associé(s) à un risque accru de développer une HTA :

- A. Antécédents familiaux d'AVC précoce
- B. Ménopause
- C. Insuffisance surrénalienne chronique
- D. Obésité abdominale
- E. Syndrome d'apnées du sommeil

Réponses : A, B, D, E

26- Parmi ces comportements alimentaires, lequel est cité comme FRCV pour l'HTA :

- A. Régime riche en sel
- B. Régime pauvre en graisses animales
- C. Consommation excessive de réglisse (glycyrrhizine)
- D. Consommation régulière de poisson riche en oméga-3
- E. Apport sodé élevé

Réponses : A, C, E

27- Concernant la prévalence mondiale et impact :

- A. Environ 1 milliard de personnes hypertendues dans le monde
- B. HTA cause $\approx$ 8 millions de décès/an selon OMS
- C. HTA est souvent responsable de complications graves
- D. Le risque cardiovasculaire augmente dès PAS 115 mmHg / PAD 75 mmHg
- E. Pas de relation dose-effet entre PA et risque CV

Réponses : A, B, C, D

Objectif 4

Facteurs étiopathogéniques de l'HTA

28- Concernant l'étiopathogenèse : l'HTA essentielle est :

- A. Dûe à une cause identifiable dans 95% des cas
- B. Résultante d'un terrain génétique + facteurs liés au style de vie
- C. Avec contribution génétique estimée à 30–40%
- D. Souvent liée à une mutation monogénique
- E. Parfois associée à hyperactivation du SRAA et du sympathique

Réponses : B, C, E

29- Médicaments susceptibles d'induire HTA :

A. AINS

B. Corticoïdes

C. Contraceptifs oraux

D. Inhibiteurs calciques

E. Ciclosporine

Réponses : A, B, C, E

30- L'hyperaldostéronisme primaire :

- A. S'accompagne d'une hyperkaliémie
- B. Présente une aldostéronémie élevée et rénine basse
- C. S'accompagne souvent d'alcalose métabolique
- D. Peut être confirmé par un rapport A/R > 25
- E. Peut résulter d'un adénome de Conn

Réponses : B, C, D, E

31- La sténose de l'artère rénale provoque :

- A. Une baisse de la rénine
- B. Une activation du SRAA
- C. Une HTA résistante
- D. Une hypovolémie
- E. Une hyperkaliémie

Réponses : B, C

32- La sténose de l'artère rénale provoque HTA principalement par :

- A. Ischémie rénale → sécrétion accrue de rénine → activation SRAA
- B. Effet direct sur la résistance systémique sans SRAA
- C. Rétention sodée plus prononcée si sténose bilatérale
- D. Souvent due à dysplasie fibromusculaire chez l'homme âgé
- E. Peut être athéromateuse

Réponses : A, C, E

33- L'HTA secondaire est suspectée devant :

- A. Une HTA sévère d'emblée
- B. Une hypokaliémie
- C. Une mauvaise réponse à la trithérapie
- D. Un âge de début < 40 ans
- E. Une obésité morbide

Réponses : A, B, C, D

34- Le syndrome de Liddle :

- A. Est un pseudo-hyperaldostéronisme
- B. Présente une aldostérone basse
- C. S'accompagne d'hypokaliémie
- D. Répond à l'amiloride
- E. Est dû à un déficit en 11 β -hydroxylase

Réponses : A, B, C, D

35- La coarctation de l'aorte :

- A. Se traduit par un gradient tensionnel MS/MI > 20 mmHg
- B. Donne un souffle systolique dorsal
- C. S'accompagne d'hypoperfusion rénale
- D. Concerne surtout le sujet âgé
- E. Peut entraîner activation du SRAA en aval de l'obstacle

Réponses : A, B, C, E

36- Parmi les causes endocriniennes listées, lesquelles sont vraies ?

- A. Hyperaldostéronisme primaire : aldostéronémie ↑, réninémie ↓
- B. Hyperaldostéronisme secondaire : Aldostéronémie ↑ et réninémie ↑
- C. Syndrome de Cushing peut causer HTA via rétention sodée et sensibilité vasculaire augmentée
- D. Phéochromocytome produit des catécholamines paroxystiques
- E. Hyperthyroïdie n'est jamais associée à HTA

Réponses : A, B, C, D

37- Hyperaldostérisme primaire :

- A. Aldostérone ↑ / rénine ↓
- B. Hypokaliémie
- C. Alcalose
- D. Réversible après chirurgie si adénome
- E. Confirmation par test au captopril

Réponses : A, B, C, D

38- Phéochromocytome :

- A. Triade céphalées-sueurs-palpitations
- B. Crises paroxystiques
- C. Diagnostic par méthoxylés urinaires
- D. Bêtabloquant seul est recommandé
- E. Imagerie pour localisation

Réponses : A, B, C, E

39- Parmi ces causes toxiques d'HTA mentionnées : lesquelles sont exactes ?

A. Réglisse (glycyrrhizine) peut simuler un hyperminéralocorticisme

B. Cocaïne peut provoquer une HTA toxique

C. Alcool chronique

D. Anorexigènes amphétaminiques

E. Érythropoïétine (EPO) peut provoquer une HTA

Réponses : A, B, D, E

Objectif 5

Diagnostic positif de l'hypertension artérielle

40- Seules les affirmations vraies concernant la MAPA (24h) :

- A. MAPA est la méthode de référence pour le diagnostic d'HTA
- B. HTA sur MAPA 24h si moyennes $\geq 130/80$ mmHg
- C. MAPA permet d'évaluer le statut « dipper / non-dipper »
- D. MAPA n'a pas de valeur diagnostique chez le jeune vu la faible prévalence d'HTA masquée
- E. MAPA mesure la PA toutes les 15–20 min le jour et 30–60 min la nuit

Réponses : A, B, C, E

41- Automesure à domicile (AMD) : bonnes pratiques :

- A. 3–7 jours, 2 mesures matin et 2 mesures soir, moyenne d'au moins 12 valeurs
- B. HTA si moyenne AMD $\geq 130/80$ mmHg
- C. Permet d'évaluer le statut « dipper / non-dipper »
- D. Permet de dépister HTA blouse blanche ou HTA masquée
- E. Doit être réalisée avec brassard adapté et position assise

Réponses : A, D, E

42- « Effet blouse blanche » et « HTA masquée » : quels sont les propositions correctes ?

- A. Effet blouse blanche = PA élevée au cabinet mais normale hors cabinet
- B. HTA masquée = PA normale au cabinet mais élevée à domicile/ambulatoire
- C. Effet blouse blanche n'augmente aucun risque cardiovasculaire par rapport aux normotendus
- D. HTA masquée est souvent révélée tardivement et présente risque élevé de complications
- E. MAPA ou AMD sont indiquées pour clarifier ces situations

Réponses : A, B, D, E

43- Concernant la fréquence de mesures et confirmation du diagnostic :

- A. Diagnostic d'HTA au cabinet peut être posé après une seule consultation si PAS $\geq$ 200 mmHg
- B. Diagnostic habituel : au moins 2 mesures par consultation sur 3 consultations successives
- C. En pratique, MAPA remplace ces confirmations si disponible
- D. Pour PA limite, on considère MAPA/AMD pour confirmation
- E. Si PA $\geq$ 180/110 mmHg on confirme sur 2 consultations rapprochées

Réponses : B, C, D, E

44- Hypotension orthostatique :

- A. Diminution PAS > 20 mmHg debout
- B. Diminution PAD > 10 mmHg debout
- C. Recherche systématique chez diabétiques
- D. Signe une HTA secondaire
- E. Exige arrêt immédiat traitement anti-hypertenseur

Réponses : A, B, C

45- Devant HTA résistante :

- A. Vérifier observance
- B. Rechercher cause secondaire
- C. Ajouter diurétique thiazidique
- D. Confirmer par MAPA
- E. Éliminer effet blouse blanche

Réponses : A, B, D, E

46- Sur la MAPA, seuils diagnostiques diurne/sommeil :

- A. MAPA éveil : HTA si PAM diurne $\geq 135/85$ mmHg
- B. MAPA sommeil : HTA si PAM nocturne $\geq 120/70$ mmHg
- C. MAPA 24h : seuil $\geq 130/80$ mmHg
- D. Seuils MAPA 24H sont identiques aux seuils de l'automesure à domicile
- E. MAPA est plus corrélée aux risques CV et pronostic rénal que mesures de cabinet

Réponses : A, B, C, E

Objectif 6

**Démarche diagnostique étiologique d'une HTA en fonction du
contexte clinique**

47- Quels éléments orientent plutôt vers une HTA secondaire ?

- A. Âge < 40 ans au début de l'HTA
- B. HTA d'emblée sévère ou aggravée sous traitement
- C. Hypokaliémie inexpliquée
- D. Antécédents familiaux d'HTA
- E. Souffle lombaire et antécédent de traumatisme lombaire

Réponses : A, B, C, E

48- En cas de suspicion d'HTA rénovasculaire, examens recommandés :

- A. Échographie Doppler des artères rénales
- B. Angio-scanner ou IRM rénale (référence)
- C. UIV
- D. Dosage de la rénine plasmatique
- E. Artériographie (aortographie rénale) si intervention envisagée

Réponses : A, B, E

49- Les signes biologiques qui orientent vers hyperaldostéronisme primaire :

- A. Hypokaliémie
- B. Aldostéronémie ↑ et réninémie ↓ (ARP bas)
- C. Ratio aldostérone / ARP (debout) > 25
- D. Alcalose métabolique possible
- E. Rénine plasmatique ↑

Réponses : A, B, C, D

50- Dans l'enquête d'un phéochromocytome, quelles démarches sont appropriées :

- A. Dosages des dérivés méthoxylés (méтанéphrines et norméтанéphrines) urinaires est l'examen de référence
- B. VMA urinaire est le test le plus fiable
- C. Imagerie (TDM/IRM surrénales) pour confirmer la localisation
- D. Préparation préopératoire par alpha-bloquant si chirurgie envisagée
- E. Administration immédiate d'un bêta-bloquant seul pour contrôler la FC est recommandée

Réponses : A, C, D

51- Quels signes cliniques évoquent une coarctation de l'aorte chez un adulte ou enfant ?

- A. HTA chez l'enfant ou jeune adulte
- B. Asymétrie tensionnelle entre membres supérieurs et inférieurs (>20 mmHg)
- C. Souffle systolique inter-scapulo-vertébral gauche
- D. Hypokaliémie sévère systématique
- E. Circulation collatérale thoracique / encoches costales sur Rx

Réponses : A, B, C, E

52- Les critères orientant vers HTA d'origine endocrinienne incluent :

- A. HTA paroxystique, triade céphalées/sueurs/palpitations → phéochromocytome
- B. Obésité facio-tronculaire, vergetures, hypokaliémie → syndrome de Cushing
- C. Hypokaliémie marquée, PA constante → hyperaldostéronisme primaire
- D. Douleurs abdominales post-prandiales → suspicion d'aldostéronisme
- E. Polyurie et polydipsie → peut être vue en hyperaldostéronisme ou phéochromocytome

Réponses : A, B, C, E

53- Examen complémentaire utile pour dépister une sténose rénale fonctionnelle :

- A. Scintigraphie au DTPA ou MAG3 avec test au captopril (possible aide diagnostique)
- B. Mesure du ratio rénine veine rénale droit/gauche systématique
- C. Echographie rénale avec étude morphologique/taille des reins
- D. Angio-CT/IRM si disponible pour confirmation
- E. UIV systématique en première intention

Réponses : C, D

Objectif 7

Évaluer le retentissement de l'HTA sur les organes cibles

54- L'hypertrophie ventriculaire gauche (HVG) en HTA est :

- A. Conséquence d'une surcharge de pression → HVG concentrique
- B. Peut évoluer vers insuffisance cardiaque diastolique puis systolique
- C. Diagnostiquée par ECG (indice de Sokolow >35 mm) ou échographie (masse VG $\geq 115 \text{ g/m}^2$ homme)
- D. Indique un risque cardiovasculaire modéré
- E. Peut favoriser la fibrillation auriculaire

Réponses : A, B, C, E

55- Atteinte cérébrale en HTA peut se traduire par :

- A. AVC ischémique et hémorragique
- B. Encéphalopathie hypertensive en formes aiguës sévères
- C. Troubles cognitifs chroniques liés à microangiopathie
- D. Une hypertension intra-crânienne
- E. Céphalées, troubles visuels possible lors des poussées

Réponses : A, B, C, E

56- Sur le plan vasculaire, l'HTA favorise :

- A. Athérosclérose des gros troncs
- B. Anévrysmes (ex. cérébraux) dans certaines maladies héréditaires associées (PKD)
- C. Thrombo-embolie veineuse par dysfonction endothéliale
- D. Remaniement pariétal et perte d'élasticité
- E. Augmentation du risque d'AVC hémorragique et ischémique

Réponses : A, B, D, E

57- Atteinte rénale liée à HTA (retentissement) :

- A. Protéinurie et/ou hématurie peuvent témoigner d'une néphropathie chronique causale ou consécutive
- B. HTA est facteur majeur d'insuffisance rénale terminale
- C. Microalbuminurie est un signe d'atteinte rénale avancée
- D. La présence d'une micro-albuminurie augmente le risque des complications vasculaires (exemple AVC)
- E. Une micro-albuminurie peut être réversible sous traitement anti-hypertenseur

Réponses : A, B , D, E

58- Le retentissement rénal se manifeste par :

- A. Microalbuminurie
- B. Diminution du DFG
- C. Hématurie macroscopique
- D. Hypokaliémie
- E. Augmentation de la créatinine

Réponses : A, B , E

59- Quels éléments indiquent un retentissement cardiaque ?

- A. HVG à l'électrocardiogramme ou à l'échographie
- B. Antécédent d'infarctus du myocarde ou revascularisation
- C. Dyspnée d'effort et insuffisance cardiaque clinique
- D. Hypokaliémie isolée sans autre anomalie
- E. Fibrillation atriale associée à HTA

Réponses : A, B , C, E

60- L'hypertrophie ventriculaire gauche (HVG) :

- A. Est un marqueur de mauvais pronostic
- B. Se diagnostique sur ECG et échographie
- C. Est toujours symptomatique
- D. Peut être réversible sous traitement antihypertenseur
- E. S'accompagne d'une rigidité diastolique

Réponses : A, B , D, E

61- Pour évaluer l'atteinte rénale liée à HTA, on doit réaliser :

- A. Recherche de protéinurie / microalbuminurie
- B. Dosage créatinine et estimation DFG (clairance)
- C. Sédiment urinaire pour hématurie/leucocyturie
- D. Ionogramme urinaire
- E. Échographie rénale pour taille et morphologie

Réponses : A, B , C, E

62- La microalbuminurie :

- A. Détecte précocement l'atteinte rénale
- B. Est un facteur de risque cardiovasculaire
- C. Peut régresser sous IEC/ARAII
- D. S'observe uniquement chez le diabétique
- E. Reflète la dysfonction endothéliale

Réponses : A, B , C, E

63- Le statut « non-dipper » est associé à :

- A. Risque CV augmenté
- B. Plus d'HVG et microalbuminurie
- C. Meilleur pronostic rénal
- D. Une prévalence élevée d'un syndrome d'apnée de sommeil
- E. Peut être mis en évidence par un automesure à domicile

Réponses : A, B , D

Objectif 8

Bilan paraclinique nécessaire avant l'instauration du traitement

64- Avant d'instaurer un traitement antihypertenseur chez un patient hypertendu, les examens recommandés comprennent :

- A. Bilan biologique (créatinine, kaliémie, glycémie, lipides)
- B. Recherche de protéinurie / microalbuminurie
- C. ECG systématique
- D. Echographie rénale
- E. Fond d'œil

Réponses : A, B , C, E

65- La surveillance initiale de la fonction rénale lors de mise en route d'IEC/ARAII nécessite :

- A. Mesure créatinine et kaliémie pré-traitement
- B. Surveillance précoce après début de traitement (2 semaines)
- C. Contre-indication absolue d'IEC en cas d'insuffisance rénale légère stable associée à une micro-albuminurie
- D. IEC/ARAII contre-indiqués en sténose bilatérale des artères rénales
- E. Surveillance biologique après 6 mois si la fonction rénale initiale est normale

Réponses : A, B , D

66- Quel bilan paraclinique est recommandé devant suspicion de phéochromocytome ?

- A. Dosage des dérivés méthoxylés urinaires (méthanéphrines)
- B. VMA urinaire est l'examen de première intention
- C. Biopsie surrénalienne scanno-guidée
- D. Dosage du cortisol libre urinaire
- E. Scintigraphie MIBG si suspicion de localisation ectopique

Réponses : A, E

67- Le bilan minimal pour évaluer le risque cardiovasculaire global chez un hypertendu avant thérapie comporte :

- A. Glycémie à jeun
- B. Bilan lipidique (cholestérol total, LDL, HDL, triglycérides)
- C. Microalbuminurie ou protéinurie 24h
- D. Test d'effort systématique chez tout hypertendu avec diabète associé
- E. ECG et éventuellement ETT selon retentissement

Réponses : A, B, C, E

68- Pour recherche d'HTA rénovasculaire, quels éléments biologiques / investigations peuvent alerter ?

- A. Hypokaliémie inhabituelle
- B. Alcalose métabolique
- C. Réninémie élevée
- D. Échographie rénale montrant asymétrie de taille rénale
- E. Aldostéronémie basse

Réponses : A, B, C, D

69- Quand demander un bilan hormonal (aldostérone/rénine) ?

- A. HTA sévère ou résistante
- B. Hypokaliémie spontanée ou persistante
- C. HTA chez un jeune (<40 ans)
- D. Toujours systématique chez tout hypertendu avec antécédents familiaux d'AVC
- E. Si suspicion d'adénome de Conn ou hyperplasie bilatérale

Réponses : A, B, C, E

Objectif 9

Évaluer le risque cardiovasculaire global d'un patient hypertendu

70- Les éléments entrant dans l'évaluation du risque CV global comprennent :

- A. Chiffres de PA
- B. Le poids du patient (IMC)
- C. Atteinte d'organe cible (HVG, microalbuminurie)
- D. Le syndrome d'apnée de sommeil associé
- E. Antécédents d'événements CV (IDM, AVC)

Réponses : A, C, E

71- Outre l'examen clinique, quels éléments paracliniques sont utiles pour le calcul du risque CV ?

- A. Bilan lipidique complet
- B. Glycémie à jeun / HbA1c selon contexte
- C. Protéinurie / microalbuminurie
- D. ECG
- E. Échographie rénale

Réponses : A, B, C, D

72- Un patient hypertendu présentant HVG échographique et microalbuminurie :

- A. Est classé à risque cardiovasculaire élevé
- B. Nécessite intensification thérapeutique et surveillance renforcée
- C. Peut être traité uniquement par mesures hygiéno-diététiques si l'HTA est de découverte récente et les chiffres tensionnels < 160/90 mmHg
- D. Doit bénéficier d'un bilan d'ischémie myocardique systématique sans autre contexte
- E. A un pronostic péjoratif par rapport à un hypertendu sans atteinte d'organe cible

Réponses : A, B, E

73- L'évaluation du risque CV global permet :

- A. De définir l'objectif tensionnel (plus strict si risque élevé)
- B. D'orienter le choix thérapeutique initial
- C. De décider de stratégie de prévention secondaire (antiplaquettaire, statine) selon présence d'atteinte clinique
- D. De chercher une cause secondaire si le risque cardiovasculaire est élevé
- E. L'abstention du traitement pharmacologique si patient asymptomatique et à risque CV faible

Réponses : A, B, C

74- Parmi les paramètres liés au risque CV majeur, lesquels sont considérés « majeurs » :

A. HTA

B. Diabète type 2

C. Tabac

D. Dyslipidémie athérogène (LDL élevé)

E. Surpoids

Réponses : A, B, C, D

Objectif 10

Conduite thérapeutique initiale face à une urgence hypertensive

75- Urgence hypertensive (définition et prise en charge immédiate) :

- A. Urgence = élévation sévère de la PA avec atteinte aigüe d'organe cible
- B. Crise hypertensive = urgence hypertensive grave nécessitant traitement IV immédiat
- C. Urgence hypertensive doit être gérée en milieu hospitalier voire réanimation
- D. Baisse trop rapide de la PA peut aggraver l'ischémie cérébrale/myocardique
- E. MAPA est l'examen de choix en situation d'urgence pour guider traitement IV immédiat

Réponses : A, C, D

76- Dans une urgence hypertensive (ex : encéphalopathie hypertensive), stratégie initiale correcte :

- A. Baisser progressivement la PA sur quelques heures (éviter chute brutale)
- B. Utiliser antihypertenseur IV titrable (ex : nicardipine, urapidil selon disponibilités locales)
- C. Administrer les dérivés nitrés par voie sublinguale
- D. Monitoring hémodynamique continu et surveillance organes cibles
- E. Traitement ambulatoire possible en cas contrôle rapide de la pression artérielle

Réponses : A, B, D

77- Face à une poussée hypertensive sans atteinte d'organe :

- A. Il est souvent possible d'effectuer une réduction progressive en ambulatoire selon la situation
- B. Traitement immédiat IV systématique est obligatoire
- C. Vérifier les causes réversibles/médicamenteuses
- D. Recommander repos, reprise des antihypertenseurs habituels si oubliés
- E. La MAPA peut être indiquée dans les suites de la poussée hypertensive

Réponses : A, C, D, E

78- Concernant la prise en charge peropératoire d'un phéochromocytome :

- A. Préparation préopératoire obligatoire par alpha-bloquant (pour prévenir crise)
- B. Bêta-bloquant seul préopératoire est acceptable en cas de tachycardie sous poussée hypertensive
- C. Association alpha-bêta ou séquence alpha puis bêta est la règle (jamais bêta seul)
- D. Monitoring invasif de la PA peropératoire est recommandé
- E. Risque majeur d'hypertension peropératoire si non préparé

Réponses : A, C, D, E

79- Pour un OAP flash lié à HTA sévère, mesures initiales incluent :

- A. Oxygène, diurétique IV (furosémide) en première intention
- B. Vasodilatateur IV si besoin
- C. IEC IV en première intention
- D. Prendre en compte la fonction rénale avant certains vasodilatateurs
- E. Nécessite une baisse tensionnelle rapide

Réponses : A, B, D, E

80- La conduite initiale face à une crise hypertensive intracrânienne :

- A. Baisser la PA avec précaution pour ne pas aggraver la perfusion cérébrale
- B. Objectif tensionnel plus strict si hémorragie intracérébrale aiguë
- C. Baisser la PAS à < 140 mmHg immédiatement quel que soit le contexte
- D. Consultation neurologique/réanimation et imagerie cérébrale urgente
- E. Ne pas utiliser d'anti-agrégant avant imagerie cérébrale

Réponses : A, B, D, E

Objectif 11

Mécanismes d'action, indications et EI des classes d'antihypertenseurs

81- Les inhibiteurs de l'enzyme de conversion (IEC) :

- A. Inhibent la conversion d'angiotensine I en angiotensine II
- B. Diminuent la sécrétion d'aldostérone secondairement
- C. Indiqués en néphropathie diabétique pour effet anti-protéinurique
- D. Contre-indiqués en cas de sténose unilatérale de l'artère rénale
- E. Effets indésirables fréquents : OMI , tachycardie

Réponses : A, B, C

82- Les IEC :

- A. Sont des antagonistes aux récepteurs de l'angiotensine II
- B. Provoquent une vasodilatation artérielle
- C. Provoquent hyperkaliémie
- D. Contre-indiqués pendant la grossesse
- E. Diminuent protéinurie

Réponses : B,C, D, E

83- Les antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II (ARA II) :

- A. Bloquent l'effet de l'angiotensine II au niveau des récepteurs AT1
- B. Ont le même profil d'efficacité antihypertenseur que les IEC en général
- C. Moins de risque de toux que les IEC
- D. Contre-indiqués en sténose bilatérale rénale (similaire aux IEC)
- E. Augmentent la production d'aldostérone systématiquement

Réponses : A, B, C, D

84- Les diurétiques thiazidiques :

- A. Réduisent la volémie
- B. Entraînent hypokaliémie
- C. Efficaces chez sujets âgés
- D. Contre-indiqués en insuffisance rénale sévère
- E. Utilisés dans HTA gravidique

Réponses : A, B,C, D

85- Les diurétiques thiazidiques (ex. hydrochlorothiazide) :

- A. Agissent au tubule proximal diminuant réabsorption Na⁺
- B. Sont efficaces en monothérapie pour HTA légère/modérée
- C. EI : hypokaliémie, hyperuricémie, perturbations lipidiques/glycémiques possibles
- D. Inefficaces chez patients âgés
- E. Utiles comme composante de trithérapie en HTA résistante

Réponses : B, C, E

86- Les diurétiques de l'anse (ex. furosémide) sont :

- A. Plus puissants que thiazidiques pour diurèse et baisse volémique
- B. Indiqués en cas d'insuffisance rénale avancée pour contrôle tensionnel/œdèmes
- C. Les médicaments de 1ère intention chez l'hypertendu agé
- D. Peuvent provoquer hyponatrémie, hypokaliémie, ototoxicité à fortes doses
- E. Efficacité indépendante du débit de filtration glomérulaire

Réponses : A, B, D

87- Les bêta-bloquants :

- A. Réduisent la FC et la contractilité via antagonisme β_1
- B. Traitement de première intention de l'HTA du sujet jeune neurotonique
- C. Contre-indiqués absolus en asthme sévère
- D. Traitement de première intention du phéochromocytome en monothérapie
- E. Effets indésirables : bradycardie, exacerbation d'asthme

Réponses : A, B,C, E

88- Les inhibiteurs calciques dihydropyridines (ex. amlodipine) :

- A. Entraînent vasodilatation artériolaire
- B. Peuvent provoquer des œdèmes périphériques
- C. Indiqués chez les personnes âgées et dans HTA systolique isolée
- D. Sont contre-indiqués en coronaropathie instable
- E. N'ont aucun effet sur fréquence cardiaque
(certains peuvent provoquer une tachycardie réflexe)

Réponses : A, B,C, E

89- Concernant antagonistes calciques non-dihydropyridines (vérapamil, diltiazem) :

- A. Agissent sur le cœur (réduction FC) et vaisseaux
- B. Peuvent être utiles en cas de tachycardie supraventriculaire associée
- C. Contre-indiqués en association avec bêta-bloquants
- D. N'ont aucun effet sur la conduction AV
- E. Effets indésirables possibles : Œdème des membres inférieurs , bradycardie

Réponses : A, B,C, E

90- Le choix initial fréquent en monothérapie selon caractéristiques du patient :

- A. Inhibiteur calcique chez chez sujet jeune
- B. IEC/ARAII chez patient avec protéinurie ou néphropathie diabétique
- C. Inhibiteur calcique (dihydropyridine) chez patient âgé avec HTA systolique isolée
- D. Diurétique thiazidique en première intention chez la femme enceinte
- E. Bêta-bloquant de première intention chez le jeune neurotonique

Réponses : B,C, E

Objectif 12

Conduite thérapeutique chez un patient ayant une HTA essentielle

91- Chez une femme en âge de procréer avec HTA essentielle, précautions :

- A. Éviter IEC/ARAI en période de grossesse
- B. Prendre en compte contraceptifs oraux qui peuvent augmenter la PA
- C. Les IEC sont sûrs pendant toute la grossesse
- D. Informer et planifier modification thérapeutique avant conception
- E. Surveillance renforcée si une grossesse est envisagée

Réponses : A, B, D, E

92- Lors du choix thérapeutique initial, quel principe est souligné ?

- A. Tenir compte du risque CV global et des organes cibles (protéger rein, cœur)
- B. Choisir un traitement efficace mais adapté aux comorbidités (diabète, BPCO, grossesse)
- C. Préférer toujours bithérapie fixe initiale quel que soit le patient
- D. Utiliser IEC/ARAII si protéinurie ou néphropathie diabétique
- E. Éviter diurétiques chez tout le monde

Réponses : A, B, D

93- En cas d'HTA systolique isolée chez le sujet âgé, classe d'antihypertenseur souvent privilégiée :

- A. Inhibiteur calcique dihydropyridine (amlodipine, nicardipine)
- B. Bêta-bloquant uniquement si angine ou tachyarythmie
- C. IEC en première intention sans considération de rigidité artérielle
- D. Thiazidique souvent utile aussi
- E. Alpha-bloquant sont souvent utiles

Réponses : A, B, D
